

核心精讲·支气管扩张症

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、支扩

1. 支扩是支气管管腔持久性扩张、**伴管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

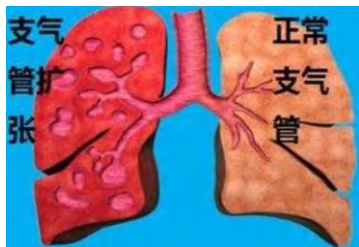


图 10-13 支气管扩张症
肺切面见多数显著扩张的支气管。

2. 病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等

3. 发病机制

慢性感染特别是 反复化脓性炎如支气管肺炎 → 破坏支气管管壁结构 （弹力纤维/平滑肌/软骨等） 支扩发生在段、小支气管，属于传导区（解剖无效腔）、气体都在气道内，当气道失去软骨等限制就会被气体的跨壁压撑大。区别于肺气肿发生在末梢肺组织、气体主要在肺泡内	支气管失去支撑结构（最主要）、管壁弹性减弱
支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化（形成大量纤维组织）	胶原纤维牵拉支气管
咳嗽→支气管管腔内的压力↑	跨壁压（管道内外压力差） ↑→气道口径被动扩大

4. 典型临床表现：长期咳嗽、**咳大量脓痰（痰盂）**、可咯血

需注意 ttsx:

①支扩咳大量脓痰等阻塞气道→**支扩属于阻塞性通气功能障碍**

（支扩的支气管虽然在扩、但也在阻）

②阻塞性通气障碍不是支扩的发病基础（**支扩的发病基础是上述三点导致扩扩扩的**）；

阻塞性通气障碍是肺气肿的发病基础

二、支扩 VS 肺气肿

ttsx	支扩	肺气肿（腺泡中央型）
有无慢支炎作为病因	√（但支扩 最主要病因是支气管炎 ）	√ 且最主要
有无肺泡间隔弹力纤维破坏（没有肺泡壁支撑结构的说法）	×	√ （弹性蛋白酶- α 抗胰蛋白酶失衡）
有无支气管管壁弹力纤维破坏	√（ 段支气管、小支气管 ） 支气管肺炎病变蔓延	√（终末 细支气管 、一级呼吸性细支气管）
有无弹性减弱	√（段、小支气管）	√（ 末梢肺组织 ）
有无 支气管管壁支撑结构 （弹力纤维/平滑肌/软骨） 破坏和管壁纤维化	√（破坏的是 有软骨支撑 的段支气管、小支气管）	√（破坏的是 没有软骨支撑 的终末细支气管、一级呼吸性细支气管）
支气管失去支撑结构是不是发病基础 	√ 且最主要 （段、小支气管失去支撑结构→扩张） 段、小支气管有软骨，扩张潜能很大；终末、一级呼吸性细支气管没有软骨，它们要扩张早就扩张了	×（终末 细支气管 、一级呼吸性细支气管→ 狭窄 ） 支气管失去支撑结构后应该是扩张 结果：大的越大、小的越小
阻塞性通气障碍是不是发病基础	×（但支扩属于阻塞性通气障碍）可感性认为它是支扩的结果	√（上述狭窄、弹性蛋白酶- α 抗胰蛋白酶失衡、疾病恶性循环致 二级呼吸性细支气管及其肺泡扩张 ）
有无 并发慢性肺心病	√（肺组织因慢性炎症广泛 纤维化 ）不要只关注支扩这个结果、要关注它的病因	√ 且最主要 （肺泡间隔 毛细血管数量减少 等）

真题解析·支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2021N37 A 导致支气管扩张症的主要病变基础是

- A. 支气管纤毛柱状上皮的鳞状上皮化生
- B. 支气管壁结构破坏
- C. 支气管壁的黏液腺大量增生
- D. 肺组织纤维化

思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

